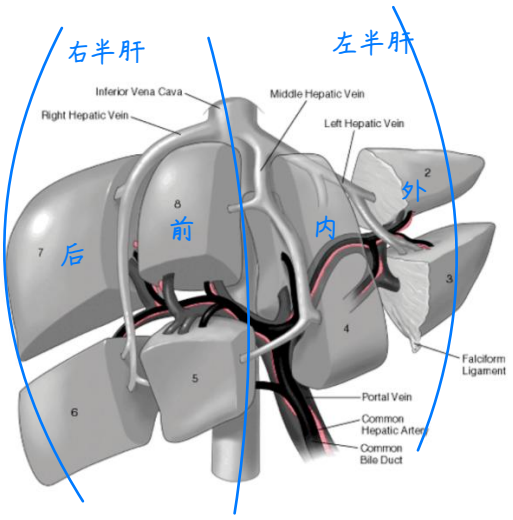
五、胆管结石

（一）肝内胆管结石及炎症

1.好发于**肝左外叶、右后叶**



部分肝内胆管堵塞

2.反复肝区、胸背部闷胀痛，多无黄疸、无胆囊增大

3.并发症

①肝内胆管炎、胆道出血、细菌性肝脓肿、脓毒症

②肝内胆管癌

③胆汁淤积性肝硬化（肝功能不全+门脉高压症）、肝衰竭

④肝外胆管结石

4.治疗

（1）无症状、小的肝内胆管结石：观察

（2）有症状

①胆管切开取石 胆囊结石切胆囊,胆管结石取石头

②**切除病变部分肝脏**：适合区域性肝内胆管结石伴纤维化、萎缩、脓肿、胆瘘；难以取净的肝段、肝叶结石伴胆管扩张；不易手术的高位胆管狭窄伴近端胆管结石；局限性结石伴胆道出血；结石伴胆管癌变

肝脏手术要注意切完肝脏会不会发生肝衰竭(不是弥漫病变)

（二）肝外胆管结石及炎症

对于肝外胆管结石及其炎症的胆囊可大可小(不用关注胆囊)

1.好发于肝总管、胆总管下段（汇合部位）

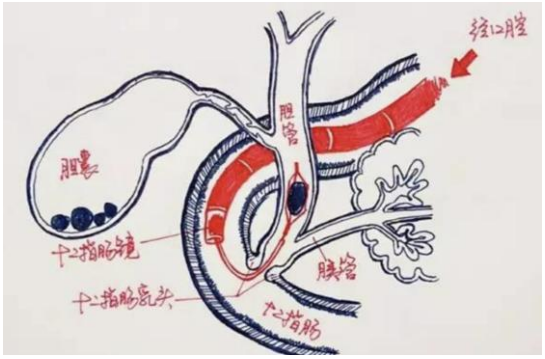
感染了

2.典型表现 **Charcot 三联征**：胆绞痛（与胆囊结石类似）、黄疸（随炎症控制发作呈**波动性**）、寒战高热

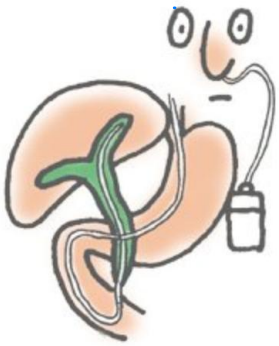
胆囊结石、胆管结石都表现右上腹胆绞痛,二者鉴别:有无黄疸(除特殊情况,如Mirizzi综合征)

3.治疗

经十二指肠内镜取石	结石≤3 枚且＜1cm
胆总管切开取石+T 管引流	胆总管结石+胆管上下通畅
内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST+取石术+鼻胆管引流术 ENBD（治疗性 ERCP）	**结石嵌顿在胆总管开口（下端）**不能取出 取或不取石头都有狭窄梗阻
胆管-空肠 Roux-en-Y 吻合术（胆汁内引流术）+**切胆囊**（没了 Oddi 括约肌就不需要胆囊了）	①胆总管**远端**炎症狭窄致**梗阻无法解除**、胆总管扩张 ②胆胰管汇合部异常、胰液直接流入胆管 ③胆管因病变部分切除、无法再吻合



急性胰腺炎手术治疗:
该保守还是要保守
必须是嵌顿在胆总管开口(B超、胆总管扩张超过1cm)→治疗性的ERCP
内镜下Oddi括约肌切开配合ENBD



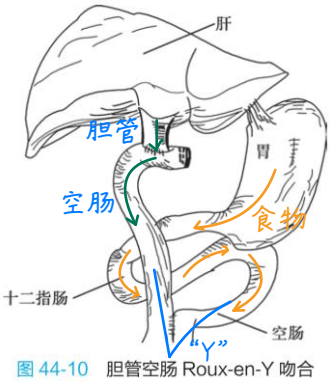


图 44-10 胆管空肠 Roux-en-Y 吻合